2020 산부인과 학년말 고사 복기

<부인과 - 46문제>
1. 29세 여성이 월경통이 심하여 내원, CA 125 89로 상승되어 있었다. 진단은?



- Tuboovarian abscess
- Hemorrhagic corpus luteum
- Serous cystadenoma
- Mature teratoma
- **Endometrioma**

2. (20년 본2) Hb=7.2, 질출혈 많이 있었다 해야 할 처치
로 옳지 않은 것은?
- 경구피임약을 7일 간 하루 34 회 치료 후 용량을 줄여서 21 일 사용한다
- 약물 치료가 되지 않으면 소파술을 한다.
- CEE 4시간마다 25mg 투여
- 수액 보충을 하면서 입원 치료를 한다
- **우선 MPA 20mg를 2번 정도 투여한다.**

3. (20년 본2) 사춘기 조발증에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오
- Bone age는 non-dominant hand나 elbow에서 측정한다.
- **여성호르몬을 투여하여 치료한다.**
- GnRH agonist를 투여하여 이차 성징의 발현을 억제하는 것이 핵심이다.
- Bone age<12세 일 때 사용하면 더 효과적이다.
- Epiphysis fusion되거나, bone/chronologic age가 일치할 때까지 치료한다.

4. (20년 본2) r/o 난소암으로 들어갔는데 frozen serous adenocarcinoma 나왔다. 환자가 안 받았을 거 같은 술기는?
- Omentectomy
- **충수절제술**
- Para aortic LN
- 전자궁
- 자궁부속기

5. 난소암 위험 제일 낮은 여성은?
- **미선: 4명의 아이를 낳은 다둥이 엄마에요.**
- 졸리: 저 55살인데 아직도 폐경을 안 했어요.
- 용녀: 모유가 잘 나오지 않아서 모유수유를 하지 않았어요.
- 재희: 아이를 2명 낳고 남편이 정관수술을 했어요.

6. 14F가 하복부 통증 및 복부팽만으로 내원하여 yolk sac tumor로 진단받고 LSO를 받았다. 향후 치료계획은?
- Radical hysterectomy + PLND
- **Chemotherapy**
- Total hysterectomy + RSO
- Simple hysterectomy
- RSO

기존 문제들
<성분화 이상, 내분비이상>
7. Pure gonadal dysgenesis(Swyer syndrome)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- 46XY
- Streak gonad
- (~~~) 외성기는 여성형이다.
- 유방이 발달하지 않는다.
- **자궁이 없다.**

8. (야마) 사춘기의 발달은 있으나 반대편 성의 소견을 보이는 Heterosexual pubertal development의 가장 흔한 원인은?
- **PCOS**
- Late-onset CAH (of 21-OH deficiency)
- Cushing syndrome
- Mixed gonadal dysgenesis

9. (탈?)Sertoli cell이 분비하는 것은 무엇인가요?
- **Mullerian inhibiting factor**
- Testosterone
- DHEA-S

<불임>
10. 체외수정과 배아이식을 위해 과배란 유도에 대한 설명. 틀린것?

- hCG 는 난자 성숙위해 난자 채취 전 34-36 시간에 투여
- **GnRH agonist 는 short protocol 이 long protocol 보다 임신률이 높다.**
- GnRH antagonist fixed protocol은 생식샘자극호르몬 투여 4-7일 후에 투여
- GnRH antagonist flexible protocol 은 난포 12-16mm 일때 투여하면 황체호르몬 분비폭발을 막을 수 있다.
- GnRH agonist 는 flare up secretion 없이 fsh, LH 분비를 억제할 수 있다는 장점이 있다.

<폐경>

11. 폐경여성의 호르몬 요법의 절대적 금기증이 아닌 것?

- 활동성 간질환 및 담낭 질환
- 활동성 혈전색전증
- 진단되지 않은 질출혈
- 현재 유방암 치료 중인 환자
- **자궁내막암 기왕력**

<PID 및 염증>

12. 우유찌꺼기 같은 하얀색 질 분비물, 외음부 가려움증으로 온 환자. 치료는?



- **클로트리마졸**
- 이미큐모드크림
- 메트로니다졸
- 경과관찰
- 클린다마이신

13. 65세 여성, 1주일 전부터 소량의 질출혈 있고 질 입구가 쓰리고 따갑다며 병원에 내원하였다. 최근 성교통과 빈뇨가 생겼다고 한다. 이학적 소견 상 질 점막의 위축이 있었고, 소변 및 질분비물 검사와 자궁경부 액상세포검사는 정상이었다. 부인과초음파 상 자궁내막 두께는 2mm 였다. 치료는?

- **에스트로겐 크림**
- 클리트리마졸 연고
- 경구 프로게스틴
- 경구 메트로니다졸
- 클린다마이신 크림

14. 여성 환자의 질경 검사 사진이다. 치료는?



- **Doxycycline**
- Ciprofloxacin
- Acyclovir
- Benzathine penicillin G

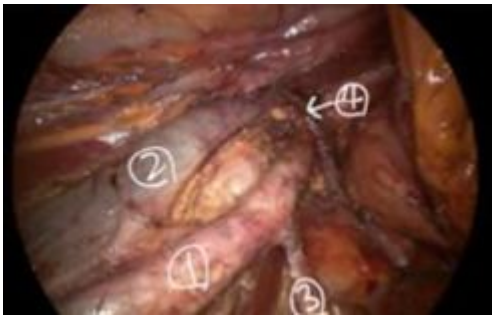
<요실금>

15. 기침할 때 소변이 나와서 내원한 여성. Q tip 검사시 40도. 요역동근 검사상 방광근의 수축은 없지만 방광내압이 요도내압을 넘어설 때 소변이 샜다. 잔뇨량은 없었다. 진단은?

- 범람요실금
- 절박요실금
- **복압요실금**
- 과민성방광

<수술사진>

16. 다음 사진의 구조물을 번호 순으로 옳게 나열한 것은?



- **abdominal aorta – inferior vena cava – left renal vein – inferior mesenteric artery**
- abdominal aorta – inferior vena cava – inferior mesenteric artery – left renal vein

17. ABCDE 순서대로 나열한 것은?(사실은 ABC만 나열하는 걸로 나왔어요.)



- **Right ureter – right uterine artery – right obturator nerve – right internal iliac vein – right internal iliac artery**
- Right ureter – right uterine artery – right obturator nerve – right internal iliac artery
- Left ureter – left uterine artery – left obturator nerve – left internal iliac vein – left internal iliac artery
- Left ureter – left uterine artery – left obturator nerve – left internal iliac artery – left internal iliac vein
- Right uterine artery – right ureter – right obturator nerve – right internal iliac vein – right internal iliac artery

18.(야마) 유사한 사진 주고 순서대로 된 것 고르기



- **Right round ligament, uterus, right ovarian ligament, right ovary, right IP ligament**

19.(야마) 유사한 사진 주고 어떤 suture인지 묻는 문제

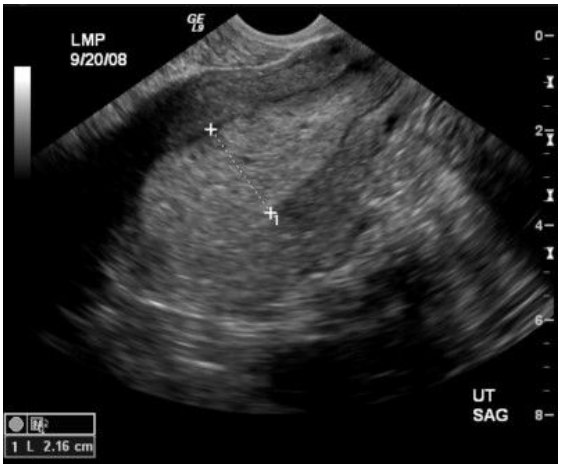




- **Vertical mattress**

<자궁내막 증식증>

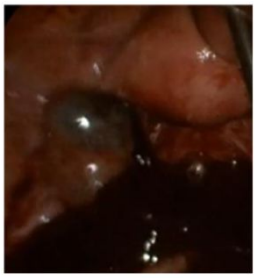
20. 폐경 후 여성이 질출혈을 주소로 내원했다. 질초음파 소견은 다음과 같다. 다음 처치는?

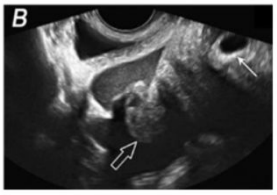


- **자궁내막생검**
- Hysterectomy
- 경과 관찰
- Progesterone

<자궁외임신>

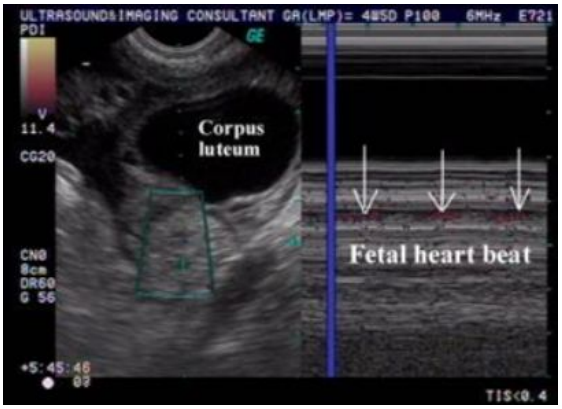
21. 29세 산과력 0-0-2-0 있는 여성이 소량의 질출혈과 하복부 통증으로 내원함. 신체진찰 상 좌하복부 자궁부속기 부분의 심한 통증과 압통 있었음. 더글라스 천자 했더니 50ml 응고되지 않은 출혈 발견하여 응급수술함. 요 임신검사 양성, WBC 8700, Hb 11, PLT 280,000. 수술 중 사진은 다음과 같다. 다음 질병의 이름은? (복강경, 초음파 다 문제와 동일한 사진 아님, 복강경 사진에는 복강 내 피 고여있었음)





- **왼쪽 난관 임신**
- 왼쪽 난소 임신
- 오른쪽 난관 임신
- 오른쪽 난소 임신

22. 28세 LMP 8주 지났는데도 생리 안하고 하복부 통증 있어서 내원. BP 90/60mmHg, HR 120회, beta-hCG 5400, Hb 8,4. 처치는?



- **복강경 수술**
- MTX 1회 투여
- 경과 관찰

116 bpm으로 초음파에 미약한 peak이 보이긴 했습니다. 그런데, 아마 엄마의 혈관이 박동하는 것이 초음파로 나타나는 것 같았습니다.(ㅠㅠ 몰라요)

<부인양성질환>

23. 20세 대학생이 3시간 전부터 시작된 극심한 좌하복부 통증 으로 응급실을 방문하였다.이 여성의 활력징후는 110/70 mmHg – 74회 – 24회 – 36.9 ℃ 였고 마지막 생리일은 2주전이었고, 성경험은 있었다. 응급실에서 시행한 CT 소견이 다음과 같다면 이 여성에서의가장 적절한 처치는?



- 입원하여 항생제 치료
- 경구피임제 투여
- **시험적 개복술 혹은 복강경수술**
- 초음파 영상 하에 needle aspiration
- 2개월 후 추적 관찰

24. 27세, 28주 산모. 초음파에서 12cm정도 mass 발견. 고형성, 내부 septation있고, 다방성임(사진으로 제시됨). 다음 해야할 것은?

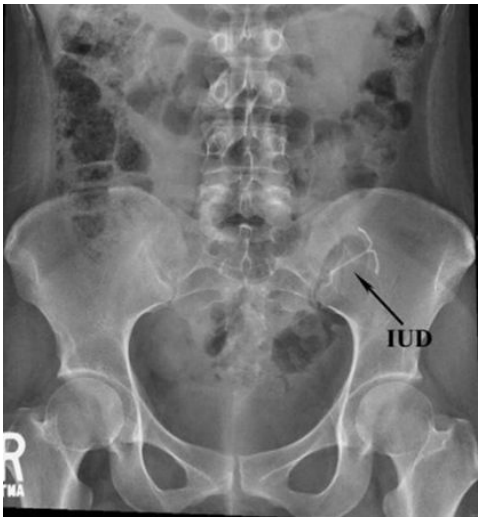
- needle aspiration
- CT
- **시험적 개복술 혹은 복강경 수술**
- 출산까지 추적관찰

<피임법>

25. 피임을 위해서 온 여자 환자. 혈전정맥증으로 치료 받은 병력이 있다. 월경과다와 월경통을 호소하고 있었음. 피임에 적합한 방법은?

- 난관결찰술
- 콘돔
- **프로게스테론 함유 mirena**
- 복합경구피임제
- 살정제

26. 29F, 타원에서 건강검진 받다가 영상에서 나타난 이상 소견으로 대학병원 외래로 찾아왔다. 환자는 별다른 증상을 호소하지 않고 아주 안정되어 있는 상태였다. 다음 처치로 올바른 것은?



- **피임효과가 더 이상 없으니 다른 피임법을 권유한다.**
- 급성 충수돌기염이다.
- 복강경 수술로 뺀다.
- 안심시키고 귀가시킨다.
- 항생제 사용

<임신융모질환>

27. 포상기태로 치료받은 환자의 피임법으로 알맞은 것은?

- 자궁내장치
- **경구피임제**
- 남성용콘돔
- 여성용콘돔

28. 산과력이 1-0-0-1인 34세 여자가 정상분만하고 5개월 간 불규칙적인 질출혈이 지속되어서 내원하였다. 흉부 X선 촬영을 시행하였을 때 지름이 2cm인 전이성 종양이 발견되었고, 당시 시행한 혈청 beta-hCG 농도는 150000이었다. 골반 초음파 검사에서 자궁 및 부속기에 특이적인 소견은 없었으며 뇌 자기공명영상 소견은 정상이었다. 자궁내막 조직검사에서 특이소견은 없었다. 이 환자에서 시행해야 할 조치는?

- 면역요법
- 단일 항암화학요법
- **복합 항암화학요법**
- 자궁절제술 후 보존적 항암요법

29. 산과력 1-0-1-1인 24세 여자가 질출혈로 내원하였다. 최종 월경일은 내원 2개월 전이었고내진에서 자궁크기는 임신 13주에 해당되었다. 오른쪽 난소는 5x4x6크기로 커져 있었다.초음파 결과는 다음과 같았고 혈청 beta-hCG 값은 120000이었다. 이 환자에서 가장 이상적인 처치법은 무엇인가?

- **흡입소파술**
- 자궁절제술
- 자궁 절제술 및 오른쪽 난소 절제술

30. 임신을 원하는 40세 여성이 불임 및 골반통증으로 내원하였다. 자궁 복강경 검사에서 양측 난소에 낭성 종괴, 자궁근종, 곧 창자 및 더글라스와의 유착을 보여주었다. 알맞은 처치는?

- **더글라스와 곧창자 박리, 난소낭종절제술, 근종 절제술**
- 더글라스와 곧창자 박리, 난소낭종절제술
- 더글라스와 곧창자 박리
- 전자궁적출술

<수술 전후 관리>

31. 50세 자궁수술예정인 여성. 약물복용력이 있었다. 다음 중 지속해야 할 약물?

- 아스피린
- 이뇨제
- 항혈소판제
- 피임약
- **항고혈압제**

32. 다음 중 수술 전 예방적 항생제를 사용해야 하는 경우는?

- 원추절제술
- 자궁내막 용종절제술
- **복강경 자궁적출술**
- 복강경 난소제거술

<자궁경부암>

33. 산과력 3-0-4-3인 53세 여성이 성교 후 질출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결과 HSIL이 나왔다. 자궁 경부에 2cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 질 확대경을 하자 자궁경부 조직검사를 시행한 생검에서 침윤성편평상피세포암으로 진단되었다. 수술 전 촬영한 MRI image는 다음과 같다. 다음으로 시행할 적절한 조치는?

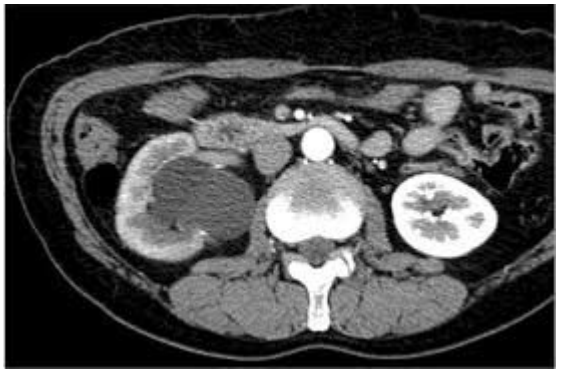


(이렇게 큰 사진은 아니었어요)



- 원추 절제술을 이미 시행했으므로 추가 치료 없이 정기적인 추적 관찰만 시행한다.
- Simple hysterectomy
- 다시 laser conization을 한다.
- Modified radical hysterectomy with pelvic lymph node dissection
- **Radical hysterectomy with pelvic lymph node dissection**

34. 산과력 4-0-5-4인 64세 여성이 몇 달 전부터 시작된 우측 옆구리 통증과 우측 다리 부종을 주소로 내원하였다. 자궁경부 전체뿐만 아니라 양측 자궁조직까지 침윤된 자궁경부 편평상피세포암이 확인되었다. 응급실에서 찍은 CT 소견은 다음과 같다. 환자의 적절한 치료법은?



- 광범위 전자궁적출술 및 양측골반임파절제술
- **항암방사선 동시 요법**
- 전자궁적출술
- 전자궁적출술 & 양측 난소난관 절제술
- 면역요법

35. 산과력 2-0-6-2인 44세 여자가 성교 후 질출혈을 주소로 내원하였다. 자궁경부 미란이 보여서 병변 부위의 생검을 시행하자 HSIL로 진단되었고, colposcopy 결과, 깊이 2mm의 침윤암이 발견되었다. 임신은 더 이상 원하지 않는다고 하였다. 이 환자에게 시행해야 할 조치는?

- 단순 자궁절제술 및 양측난소난관절제술
- **단순 자궁절제술**
- Conization
- 광범위자궁절제술

36. 이전에 cervix에 국한된 cancer history로 인해 수술 후 퇴원했는데, f/u 중 남아있는 질에 squamous cell carcinoma 발견. 원격 전이나 LN전이는 없다. (이전에 방사선 치료를 받았다는 내용 적혀있지 않음) 어떤 치료를 해야 하는가?

- 항암화학요법
- 국소항암요법
- 면역요법
- 3개월 관찰
- 방사선 치료

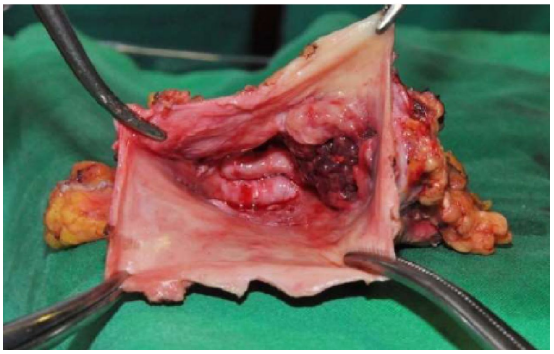
37. 산과력이 2-0-1-2 인 60 세 여성이 자궁경부암으로 치료를 받았다. 근치적 자궁절제술 및 배막뒤림프절절제술을 시행 받았다. 수술 소견은 다음과 같고 대동맥 근처 림프절은 전이되지 않았다. 병기와, 다음으로 해야 할 처치를 고르시오



- **IIIC1, 동시 항암화학방사선치료**
- IIIC2, 동시 항암화학방사선치료
- IIIC1, 항암화학요법
- IIIC2, 항암화학요법

<외음암 및 질암>

38.다음 그림에 관해 틀린 것을 고르시오.



- 상부 후벽에 흔히 발생한다.
- 수술 후 방사선요법이 효과적이다.
- **수술 후 항암요법이 반드시 필요하다.**
- PAP에서 잘 안나오므로 시진이 중요하다.

39. (야마) uterine prolapse TVL=6cm. 처녀막부터 거리는 3cm. Stage는?

- 1
- 2
- **3**
- 4

40. 다음중 외음부 암의 설명에 관해 옳지 않은 것은?

- scc가 가장 흔하다
- malignant melanoma가 두번째로 흔하다
- 여성생식기 종양의 5%정도를 차지하나, 진단 까지 오래 걸리는 양상을 보인다.
- 근치적 외음부 절제술을 시행 후 가장 흔한 초기합병증은 수술부위 벌어짐이다.
- **항암화학요법이 수술보다 좋은 치료이다.**

<난소 및 난관암>

41.다음 난소암의 병기를 설정하시오.
56세 여성 난소암 종양 감축술 받은 뒤 병리 검사 결과가 다음과 같다. Stage는?

Serous adenocarcinoma moderately differentiated right & left ovary 둘다 침범
Capsule 침범
Washing cytology (+)
Pelvic LN mets (+) 7mm
Para aortic LN mets (-)
Omentum (-)

- 1C1
- IIB2
- **IIIA1(i)**
- IIIC1(ii)

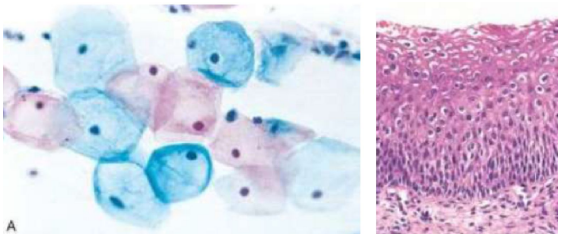
42. 17세 여자 복부통증으로 응급실 왔을 때 AFP가 14000으로 높고, 나머지 hCG, CA125, CA19-9는 낮았다. 진단은?

CA125	216.6IU/mL
CA19-9	11.7IU/mL
aFP	14472ng/mL
b-hcg	<0.1mIU/mL

- **Endodermal sinus tumor**
- Dermoid cyst
- Choriocarcinoma
- Dysgerminoma

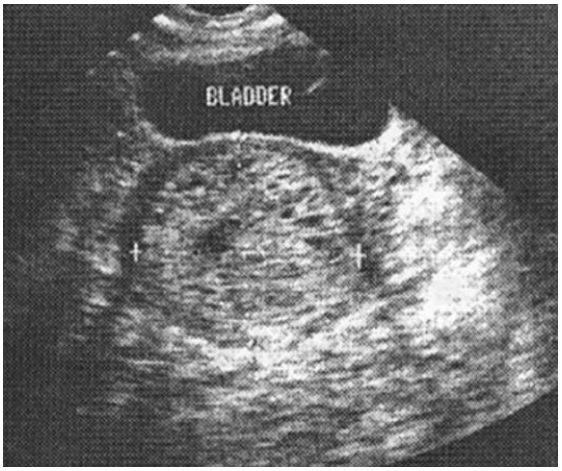
<상피내 질환>

43. 20대 여성이 세포진 검사 결과 첫번째 사진의 결과가 나와서 biopsy 를 실시했더니 결과가 다음과 같았다. 향후 계획은?



- **경과관찰**
- Conization
- 자궁절제술

44. 34세 여자가 질출혈을 주소로 내원했다. 평소 월경 주기는 28일로 규칙적이었는데 최종 월경 시작일이 8주 전이었다고 한다. 골반 검사에서 자궁이 커져있었고, 초음파 소견은 다음과 같다. 다음 처치는?



- 탐색적 개복술
- **D&C**
- 경과관찰
- Oral contraceptive

<IVF & ET - 황정혜>(전체 20년 본2)
45. 다음 중 난소 기능이 저하되지 않은 정상 소견은?

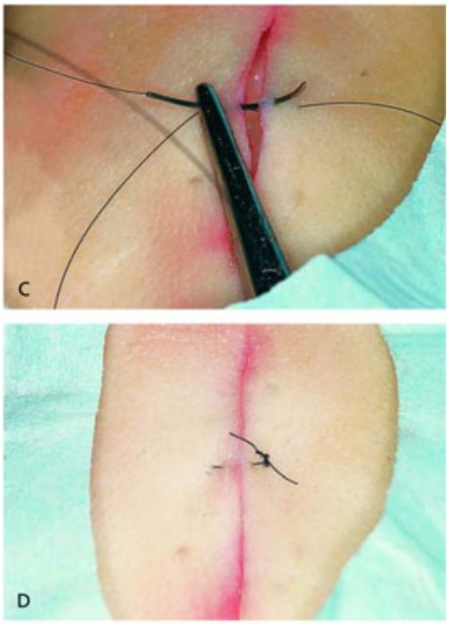
- Antral follicle <4
- Day10 FSH=30 after CCCT
- Day3 FSH=20IU
- Day3 Estradiol = 90pg/ml
- **AMH=2.1 ng/ml**

46. 다음 중 불임치료 과정에서 progesterone의 투여 시기로 알맞은 것은?

- GnRH agonist 투여 직후
- **난자 채취 당일**
- 배아 이식 직후
- 임신 확인 직후

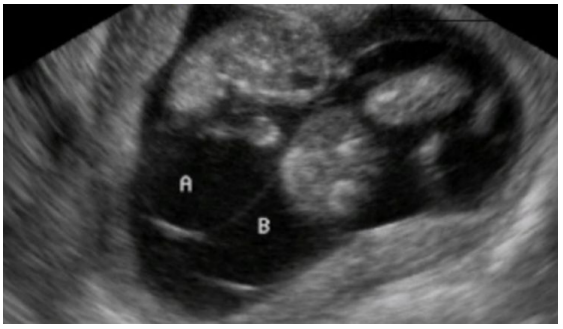
<산과-39문제>
1. 임신 11주 여성이 병원에 내원했다. 초음파 검사 결과 태아는 9주이고 심장 박동은 없다. 처치는?
- 프로게스테론
- 자궁 긁어냄술
- 1주 뒤 초음파 검사
- hCG 검사

~~2. 다음 suture의 이름은?~~



~~- vertical mattress suture~~
~~- external continuous suture~~

3. 다음 초음파 사진과 같은 종류의 쌍둥이를 무엇이라 하는가?



- Dichorionic diamniotic twins
- Monochorionic diamniotic twins
- Dichorionic monoamniotic twins
- Monochorionic monoamniotic twins

4. 생리주기가 불순한 여자가 7주동안 생리가 없어서 병원에 내원했다. 초음파 검사를 했을때 임신낭이 관찰되는 정상임신이었다. 가장 정확하게 제태기간을 측정할 수 있는 방법은?
- CRL
- femur length
- abdominal circumference
- head circumference
- BPD

5. 42세 여성 copper iud 했던 여성으로 생리가 나오지 않아 병원에 내원. 초음파 검사결과

임신 8주로 나왔고, 내진 결과 자궁 경부에서 실이 보인다. 조치는?
- 경과관찰
- IUD 제거
- 복강경 수술

6. 임신시 일어나는 모체의 생리적 변화로 옳지 **않은 것**
- 유방의 크기와 모유생성량은 상관없다
- 임신 시 질의 산도는 pH3.5~6 로 유지 된다.
- 임신 시 태아에 glucose 공급을 위해 약간 diabetogenic한 상태가 된다
- Angiotensin II 혈압상승 작용에 대한 저항성이 감소한다
- 임신시 albumin 량이 저하된다.

7. 36 세 임산부가 임신 16 주에 quad test 결과가 1:75 로 양성으로 나왔다. 초음파 검사를 시행하였고, 태아 크기는 임신주수인 16 주에 합당했다. 다음으로 해야 할 검사는?
- Quad test 를 재검한다
- 1 주 뒤 정밀 초음파 검사를 시행한다.
- 즉시 양수 천자를 통해 태아 DNA 검사를 실시한다.
- 빠르게 결과가 나오는 융모막융모생검을 실시한다
- 탯줄 천자를 통해 태아 DNA 검사를 실시한다

8. 다음은 태아 선별 DNA 검사에 대한 설명이다. 옳은 것들의 조합은?
가. 35 세 이상의 저위험군 임산부에게 가장 적절한 모체혈청검사이다
나. 모체 혈액 내 태아 DNA 는 임신 4 주 부터 검출되며, 200 base pair 이하의 작은 조각으로 분만후 2 시간 이내에 모체 혈 액에서 사라진다
다. 21, 18, 13 세 염색체, 성염색체 수적이상, 미세결실의 선별이 가능하며, 다운증후군의 경우 검출률이 99%이다
라. 임신 10 주 이후에 시행하며, 다태임신의 경우 권고되지 않는다.
- 가나다라
- 라
- 나라
- 가다
- 가나다

9. 임신 36 주, 산모가 다량의 질출혈로 내원했다. 혈압은 90/60 맥박은 110/분이였다. 적절한 처치는?
- 제왕절개
- 경과관찰
- 옥시토신
- 양수천자

10. 쌍둥이 37주 둘 다 두위. 산모가 원해서 자연분만 시작했고 한 명은 잘 나옴. 한 명이 10 떨어짐 분동안 .진행 없었고 HR 130 → 70까지 떨어짐
- 제왕절개
- 옥시토신

11.루프스에 대한 대증치료로 인도메타신 복용하는 임산부가 내원하였다. 초음파로 확인해야 하는 혈관 무엇인가?
- 제대 정맥
- 동맥관
- 정맥관
- 제대 동맥
- 자궁 동맥

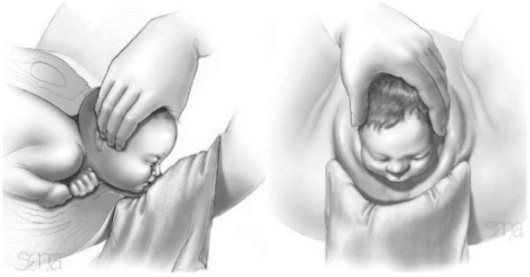
12.임신시 일어나는 모체의 생리적 변화로 옳지 않은 것은?
- 자궁의 크기는 임신전 10ml 에서 임신 후 1100ml 까지 증가한다
- 임신 8 개월에 자궁은 칼돌기높이까지 올라온다
- Pregnancy luteoma 는 모체의 남성화를 유발한다.
- NO 가 강력한 혈관확장 작용한다

13.NST 에서 reactive이고. 30 분간 측정 시 30초 이상 태아의 호흡이 지속되는 것이 2 회이상 관찰되었다. 팔 다리의 움직임은 30 분 동안 2 회 관찰되고 사지의 신전과 굴곡은 관찰되지 않았다. Single vertical pocket 의 크기가 2.5cm 였다. BPP score 구하세요.
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10

14.임신 38 주, 35 세인 산모가 진통으로 내원하였다. 자궁경부 개대가 3cm, 자궁 경부

소실도가 50% 아두하강정도 경부의 위치는 -2, 경부는 부드러웠으며, 경부의 위치는 앞쪽이었다. Bishop score 를 구하시오.
- 2
- 4
- 6
- 8
- 9

15.Spontaneously delivery 과정 중 다음 maneuver 의 이름은?



- Ritgen maneuver
- Muller's maneuver
- Mauriceau's maneuver
- McRobert's maneuver
- Pinard's maneuver

16.다음 중 자궁 수축제로 쓰이지 않는 것은?
- Ketamin
- PGF2a
- 옥시토신
- ergonovine
- methylergonovine

17. 다음 중 임산부 산전관리에 관한 설명 중 틀린 것은?
- 다태임신의 경우 철을 30mg/day 섭취한다.
- 비타민 A는 1 일 10,000U 이상 섭취하였을 경우 선천성 기형의 위험이 증가하므로 주의해야 한다.
- 카페인은 1 일 300mg 이하로 섭취하도록 한다

18.가다실 백신의 접종이 남은 여성 환자가 임신을 하였다. 옳은 설명
가. 인유두종 바이러스 백신은 비활성화 백신으로 임신 중에 접종 가능하다.
나. 인플루엔자 백신은 불활성화 백신으로 유행시기에 임신 중, 임신 전, 분만 후 모두 접종을 권고한다.
다. 풍진 백신은 불활성화 백신으로 임신 중에 접종 불가능하다.
라. 백일해가 유행하는 경우 DTaP 백신을 임신 중 접종할 수 있다
- 가나다라
- 라
- 나라
- 가다
- 가나다

19.aFP가 감소할 수 있는 경우로 옳은 것은?
가. Trisomy of 21
나. 저체중 산모
다. 과도하게 측정된 GA
라. 식도 폐쇄
- 가나다라
- 라
- 나라
- 가다
- 가나다

20.다음은 태아 선별 DNA 검사 결과에 대한 설명이다. 옳은 것들의 조합은?
가. 저위험군이며 soft sign 의 경우에는 침 습적 검사를 권유하지 않는다.
나. 저위험군이며 major anomaly 의 경우에는 침습적 검사를 반드시 권유한다.
다. 고위험군은 반드시 침습적 검사를 권유한다.
라. No call 그룹에서도 2.7%의 염색체 이상이 보고되고 있기 때문에 다시 한 번 태아 선별 DNA 검사를 해야한다.
- 가나다라
- 라
- 나라
- 가다
- 가나다

21. 임신 38 주인 32 세 미분만부가 규칙적인 진통이 있어 병원에 왔다. 7 시간 후 자궁목10cm 확장, 100% 소실, 태아 아두하강도 -1 이었다. 전자 태아심박동-자궁수축감시에서 자궁수축력은 280 Montevideo unit 으로 나타났다. 처치는?
- 제왕절개
- 옥시토신
- 맥로버츠 수기

22.41 세 임신 13 주로 내원하였다. 과거 임신전부터 고혈압이 있었고, 29 주에 임신중독증으로 진단받아 30 주에 임신 중절한 경험이 있었다. 현재 nifedipine 을 복용 중이며 혈압은 120/80mmHg 이다. 현 상태에 대한 처치로 옳은 것은?
- 고용량 아스피린 추가
- 저용량 아스피린 추가
- ACE inhibitor 로 고혈압 약 대체
- 이뇨제 복용 추가

23.첫 아이를 제왕절개로 분만한 33 세 임신 37주 산모가 진통으로 내원하였다. 산모는 찌르는 듯한 통증을 느꼈으며 이후 질출혈과 함께 태아 심음이 잘 들리지 않았다. 진단은?
- 잔류태반
- 자궁내 감염
- 자궁파열
- 산도열상
- 자궁이완증

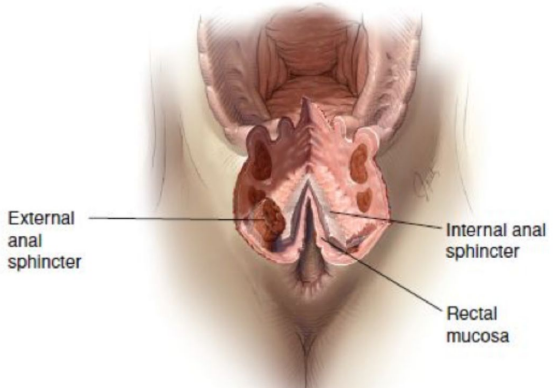
24.진통억제제 중 다음과 같은 특성을 가지는 것은?
칼슘길항작용
과량 시 호흡부전
태아 neuroprotective
- 리토드린
- 황산마그네슘

25. 발생 원인은?



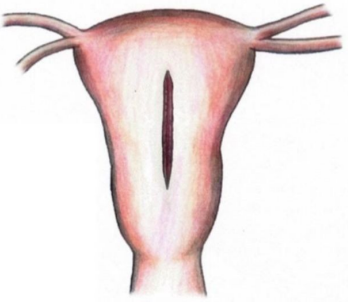
- 당뇨
- 양수과다증
- 융모양막염
- 미숙아
- 전치태반

26. 회음부 절개 한 임산부 다음의 grade는?



- grade 4 perineal laceration
- grade 3 perineal laceration
- grade 2 perineal laceration
- grade 1 perineal laceration
- cervical laceration

27. 분만 임박한 산모. 과거에 제왕절개 했었음.제왕절개 방법은 그림으로 보여줌. 조치는?



- 응급 제왕절개
- 유도분만

28. 26주 35세 미분마부가 50g OGTT 결과가 145로 나왔다. 다음으로 해야 할 것은?
- 100g OGTT
- 50g OGTT 재검사
- 인슐린
- 경과관찰

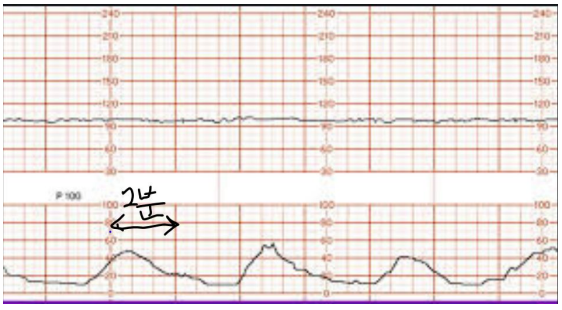
29. 임신 36주인 산모가 심한 두통으로 내원하였다. 단백뇨(3+/3+), 부종(2+/2+), 혈압 190/100 자궁목 확장과 숙화는 관찰되지 않았다. 처치는?
- 분만
- 경과관찰
- 제왕절개

- 칼슘 글루코네이트

30. 임신 38주 32세 다분만부가 분만 진통으로 내원하였다. 전자태아심박동, 자궁수축검사에서 자궁수축이 3분 간격으로 규칙적으로 관찰되었다. 자궁 크기는 정상이었다. 시간 경과에 따른 골반검사 결과가 아래와 같을 때, 처치는?

	자궁경부개대	하강도
오전 1시	3cm	-3
오전 2시	4cm	-2
오전 3시	5cm	-1
오전 4시	6cm	0
오전 5시	6cm	0
오전 6시	6cm	0

NST는 다음과 같다.



(Montevideo Unit 다 합쳤을때 200이하였습니다. FHR acceleration있었습니다.)
처치는?
A. 옥시토신
B. 제왕절개
C. 리토드린
D. 베타메타손

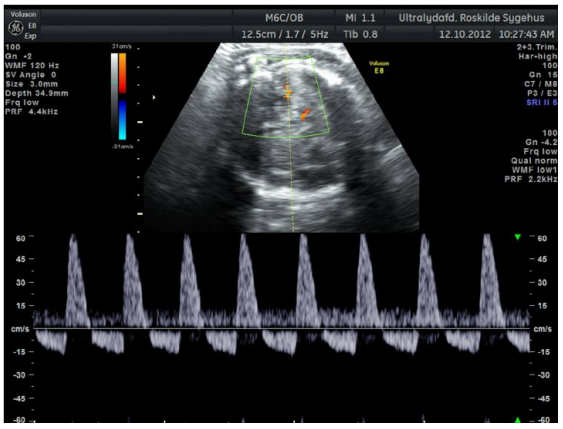
31. (DCDA USG 제시) 임신 11주차 37세 여성이 태아 평가를 위해 내원하였다. IVF-ET로 임신에 성공하였다. 2주 전 검사에서 두 태아 모두 심박동이 들렸으나 한 태아가 임신 주수에 비해 크기가 작았다. 이번 검사에서 한 태아는 임신 9주차, 태아 심박동 들리지 않았으나, 다른 태아는 정상 주차에 FHR 정상이었다. 다음 중 올바른 처치는?



A. 경과 관찰
B. 자궁긁어냄술
C. 프로게스테론
D. 코르티코이드
E. Aspirin

32. 자궁근종절제술 수술력이 있는 산모가 분만 통증으로 내원하였다. 산모는 찌르는 듯한 통증을 호소하였다. BP 80/60mmHg, Pulse 115/min일 때, 가장 의심되는 진단명?
A. 잔류태반
B. 자궁내감염
C. 자궁목열상
D. 자궁이완증
E. 자궁파열

33. 25세 여성 33주 임신. 태동 감소를 주소로 내원. NST정상. 초음파 검사 상 예상되는 태아 무게 1900g(5백분위수 미만)-IUGR이라고 명시해줌. 양수지수 5cm 으로 보였다 태아는 두위였다. 태아배꼽동맥도플러 사진이다. 다음에 절차는?

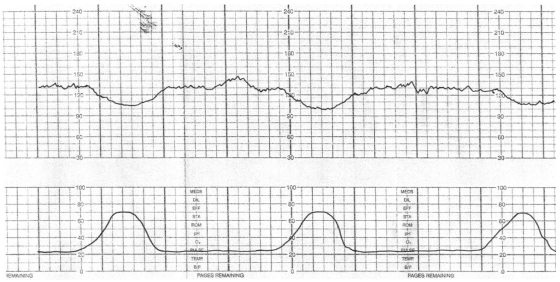


A. 1주 뒤 NST 검사
B. BPP 측정
C. 유도분만
D. 제왕절개술
E. 스테로이드 투여

34. 다음 중 정상적으로 임신 중에 일어나는 생리적 변화로 옳지 않은 것은?
A. 임신 후 3개월이 경과하면 초유가 나올 수 있다.
B. 임신 시에 간 크기의 증대나 간 조직의 변화는 없다.
C. Albumin 수치가 현격하게 감소한다.
D. 담즙의 생성이 증대되어 임신 가려움증이 생길 수 있다.

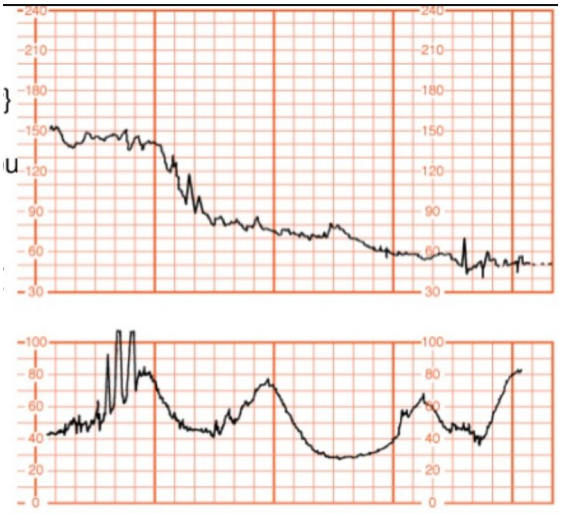
35. 임신 중 고혈압에 대해 옳지 않은 것은?
A. 산모의 혈압이 높은 경우 태반조기박리가 3배 등가한다
B. 혈관 내피의 파괴에 의해 혈소판과 피브린이 침착되어 hemolysis가 나타난다
C. 저용량 아스피린을 추가하면 전자간증으로의 진행을 예방할 수 있다
D. 혈압을 낮추기 위해 ACE inhibitor를 사용한다

36. 다음과 같이 나타날 수 있는 원인은? (정말 명확해서 헷갈리지 않았어요, Early deceleration NST)



A. 태아두부압박
B. 태반기능부전
C. 탯줄압박

37. 처치는?



A. 응급제왕절개

38. 임신 37주 산모가 4000g의 아이를 분만한 후 출혈이 지속되고 있다. 자궁은 배꼽 밑에서 단단하게 촉지되었으며 만출된 태반은 정상이었다. 가장 의심되는 것은?
A. 자궁목열상
B. 전치태반
C. 자궁무력증
D. 잔류태반
E. 자궁파열

39. 정상 질식분만한지 3주가 지난 모유수유중인 여성의 왼쪽 유방에서 급격한 출혈과 함께 고열, 오한이 났다. 유방은 딱딱해지며 붉게 피부 변화가 있었다. 초음파 검사상 농양은 없었다. 피부 소견이 다음과 같을 때 해야할 처치는?



A. 항생제 주입
B. 유방마사지
C. 절개 후 배농
D. 경과관찰

40. 29세 임신 34주의 임산부가 병원에 내원하였다. BPP가 8점이었고 single vertical pocket=2cm였다. 조치는?

A. 1주뒤 BPP측정
B. 분만
C. 비수축검사
D. 응급제왕절개

-> BPP8점, 양수과소만 있는 경우 류기영 교수님이 출제했다면 답이 경과관찰, 호정규 교수님이 내셨다면 답이 분만입니다. 위 문제는 호정규 교수님이 내신 것이라 판단, 분만 골랐습니다. 류기영 교수님 문제는 좀 더 KMLE처럼 설명이 장황해요.